EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 94157
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-10-04 10:40:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: LUCILA DEL CARMEN MIRANDA MALDONADO			RUN	: 4.617.346-5
F.Nac	: 03-08-1939	Edad	: 85 AÑOS, 2 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: 11 SEP. CIRUELO 820			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 984201899		
Fecha Ingreso	: 2024-09-28	Fecha Egreso	: 2024-10-04 10:40:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. K52.9-COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS, NO ESPECIFICADAS

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Enterocolitis aguda
2. FA en TACO
3. HTA
4. ERC etapa IV
5. Obs IC
6. Tu renal izquierdo en estudio

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. K52-OTRAS COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. I48-FIBRILACION Y ALETEO AURICULAR (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. N18.4-ENFERMEDAD RENAL CRONICA, ESTADIO 4 (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente ingresa urgencias el 27/09 con cuadro de fiebre, dolor abdominal y deposiciones liquidas (segunda consulta) de 3 días de evolución. Así mismo tos y malestar general.
PCR 289.9 Creat 2.3 (basal 2.1-1.9) ELP 138/5.2/102 Hb /Hto 13.5/41.9 Plaq 150000
Se recibe en sala en regulares condiciones clínicas refiere mialgias y malestar general
Hemodinamia estable, mucosa oral seca, bien perfundida
Cardiopulmonar: MP+ sin agregados, RsCsRs NAS
Abdomen: blando, depresible, no doloroso. RH+
Extremidades: simétricas, sin edema ni signos de TVP
Se procede a ingreso para estudio e inicio de terapia ATB
Durante estadia se procede a inicio de estudio con TAC AP, donde se describe riñón izquierdo se observa una imagen nodular hipervascular de contornos parcialmente delimitados de 3,7 x 2,5 cm, diverticulos en colon sin cambios inflamatorios
coprocultivo (-), leucos fecales (+), rotavirus y adenovirus (-)
Con reespuesta torpida a esquema ATB inicial, se escala a piperacilina/TAzobactam por 24 hrs, de forma psoterior se desescala a terapia ATB biasociada inicial

Paciente HDN estable, afebril, refiere algia lumbar al interrogatorio dirigido, con buena tolerancia a alimentacion VO, sin episodios de nauseas y/o vomitos, deposiciones 750 cc, ayer, pastosas, liquidas, diuresis 1050 cc

Examenes de lab -> lactato 0,9; PCR 52,1; uremia 44; Na/K/Cl 138/4.6/110; Hb/HCto 11.9/36.5; Gb 7,5; plaq 193000; segment 72%, TSH 10,058; T4L 1,19
Toxinas C Difficile (-)

HC (-)

Ex fisico -> Vigil, CLOTE; mucosas rosadas, hidratadas, llene capilar < 2 segs
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+) SRA
Abdomen BDI, RHA (+), sin megalias, sin signos de irritacion peritoneal
Extremidades sin edema, sin signos de TVP

Paciente actualmente cursando su dia N° 3 de ceftriaxona, dia 2 metronidazol, en condiciones de continuar hospitalizacion via HODOm

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflicto
2) Ventilatorio: Estable, wsin conflcito
3) Gi: Actuelmente en su dia N° 3 de terapia ATB, se compeltaran 7 dias de terapia ATB total, control con examenes dentro de 72 hrs
4) Urologico: Pendiente evaluacion de lesion real, se controlara de forma ambulatoria

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo: relativo asistido
2. Régimen: papilla a tolerancia aporte de agua oral 1litro /24hrs
3. Ceftriaxona 2gr ev dia por 4 dias mas
4. Metronidazol 500mg c/8hrs VO por 5 dias mas
5. Omeprazol 20mgrs vo dia por 5 dias
6. Carvedilol 12.5mgr vo cada 12hrs por 5 dias
7. Paracetamol 500 mg, 2 comp c/8hrs VO por 5 dias
8. Tramadol 10gotas c24h
9. Metoclopramida 10 mg c/12 hrs VO por 5 dias
10. Loperamida 2 mg c/!2 hrs VO por 5 dias
11. Dolospam un comp c/8hrs VO por 5 dias
12. Sertralina 50mgrs vo dia por 5 dias
13. Pendiente IC a urologia (ambulatoria)
14. Examnees de control 07/10

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO